Quality of Care

Οι 25 δείκτες ποιότητας στα νοσοκομεία της Ρουμανίας

Ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και διδάγματα για τη διοίκηση



Γεώργιος Αγγελόπουλος
Σύμβουλος, Γραφείο Αθηνών για την Ποιότητα της Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών

2 Νοεμβρίου 2026 • Αθήνα

Η συνεργασία ΠΟΥ και Υπουργείου Υγείας της Ρουμανίας

Ιούνιος 2022: συμφωνία τεχνικής υποστήριξης για μεταρρυθμίσεις στην υγεία,
με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Τρεις βασικοί άξονες συνεργασίας

Ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία

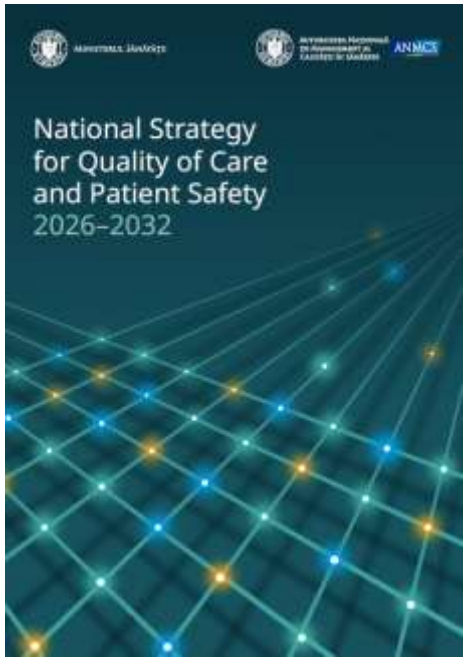
Ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και ασφάλεια των ασθενών

Το Γραφείο Αθηνών ανέλαβε τον άξονα της ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών.
Τους άλλους δύο ανέλαβαν οι αρμόδιες τεχνικές μονάδες του ΠΟΥ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Τα τρία έργα του γραφείου μας στη Ρουμανία



Pay for quality
Τεχνικός οδηγός 25 δεικτών



Εθνική στρατηγική
Ποιότητα υπηρεσιών υγείας
και ασφάλεια ασθενών



Χάρτης Υγείας

Λήψη τεχνικού οδηγού

who.int/romania/publications

Από το αίτημα του Υπουργείου στην εφαρμογή

2022–2023	Επισκόπηση βιβλιογραφίας, αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, και γύροι διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες και επιλογή των 25 δεικτών
2023	Έγκριση των δεικτών με την ΥΑ 2567/2023 και πιλοτική εφαρμογή σε έξι νοσοκομεία
Οκτώβριος 2023	Συνάντηση με τα πιλοτικά νοσοκομεία για τα αποτελέσματα, τις δυσκολίες συλλογής δεδομένων και τις αναγκαίες αλλαγές
Δεκέμβριος 2023	Έγκριση των κανόνων επιλογής και χρηματοδότησης των νοσοκομείων με την ΥΑ 4201/2023: pay for data και pay for quality
2024	Έκδοση του τεχνικού οδηγού του ΠΟΥ με τους ορισμούς και τη μεθοδολογία υπολογισμού των 25 δεικτών

Πηγές: Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024)· 3η Τεχνική Έκθεση NRRP (2023), σ. 33–34· ΥΑ 4201/14.12.2023.

Η διοικητική πρόκληση πίσω από τους δείκτες

Ένα σύστημα με μεγάλη εξάρτηση από τα νοσοκομεία

Η πρωτοβάθμια φροντίδα βασίζεται κυρίως σε ατομικά ιατρεία οικογενειακών γιατρών. Τα κενά πρόσβασης, οι ελλείψεις γιατρών και η περιορισμένη κάλυψη εκτός ωραρίου αυξάνουν την προσφυγή στα νοσοκομεία και στα επείγοντα.

Ανάγκη για συγκρίσιμα δεδομένα ποιότητας

Τα δεδομένα προέρχονταν από διαφορετικά συστήματα και δεν ήταν εύκολο να συγκριθούν μεταξύ νοσοκομείων.

Στόχος του Υπουργείου: σύνδεση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων με την επίδοση και τη βελτίωσή τους σε καθορισμένους δείκτες ποιότητας.

Πηγές: European Observatory, Romania: Health System Review (2026)· Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024), κεφ. 1–2.

Η χρηματοδότηση σχεδιάστηκε σε δύο στάδια

Στάδιο 1 • Pay for data

Αρχικά, αξιόπιστη καταγραφή και υποβολή στοιχείων από τα νοσοκομεία.

Στάδιο 2 • Pay for quality

Στη συνέχεια, αξιολόγηση της επίδοσης και της βελτίωσης με συγκρίσιμα δεδομένα.

Προβλεπόμενο μοντέλο δύο σταδίων. Πηγή: WHO Athens Office, Achievements II (2024).

Οι 25 δείκτες σε τέσσερις θεματικές κατηγορίες

09	**Ασφάλεια ασθενών**	Λοιμώξεις, πτώσεις, έλκη πίεσης και ασφάλεια στο χειρουργείο
02	**Εμπειρία ασθενών**	Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και εμπειρία μετά το εξιτήριο
03	**Ανθρώπινο δυναμικό**	Εκπαίδευση, τραυματισμοί από αιχμηρά και εμβολιασμός
11	**Αποτελεσματικότητα φροντίδας**	Θνητότητα, επανεισαγωγές, διάρκεια νοσηλείας και ισχαιμικό ΑΕΕ

Πηγές: Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024), πίν. 3· συνοπτική αποτύπωση έργου ΠΟΥ Αθηνών (2026).

Η επιλογή των 25 δεικτών

Κλινική χρησιμότητα

Προτεραιότητες για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών στο ρουμανικό σύστημα υγείας.

Επιστημονική τεκμηρίωση

Διεθνής βιβλιογραφία και καθιερωμένες προδιαγραφές για τον ορισμό και τον υπολογισμό των δεικτών.

Δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης

Διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεδομένων και εμπειρία από τη συλλογή τους στα έξι πιλοτικά νοσοκομεία.

Η συλλογή δεδομένων ακολουθεί τις καθορισμένες προδιαγραφές κάθε δείκτη.

Πηγή: Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024), περίληψη και §1.2.

Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού για κάθε δείκτη

Παράδειγμα: λοιμώξεις αίματος που σχετίζονται με κεντρικό φλεβικό καθετήρα

Αριθμός επιβεβαιωμένων λοιμώξεων σε έναν μήνα

ανά 1.000 ημέρες χρήσης κεντρικού φλεβικού καθετήρα

Για τον συγκεκριμένο δείκτη, ο τεχνικός οδηγός ΠΟΥ ορίζει τα κριτήρια λοίμωξης, τον αριθμητή και τις ημέρες χρήσης καθετήρα που αποτελούν τον παρονομαστή.

Πηγή: Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024), πίν. 4.

Οι δείκτες εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε έξι νοσοκομεία

6 **δημόσια νοσοκομεία**

Επί 60 ημέρες, τα έξι νοσοκομεία κατέγραφαν και υπέβαλλαν δεδομένα για τους δείκτες μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Στη συνάντηση εργασίας της 6ης Οκτωβρίου 2023, τα νοσοκομεία παρουσίασαν τις δυσκολίες συλλογής δεδομένων και πρότειναν αλλαγές στους ορισμούς και τον υπολογισμό των δεικτών.

Πηγές: WHO Athens Office, Achievements I (2024)· 3η Τεχνική Έκθεση NRRP (2023), σ. 33–34.

Η μέτρηση χρειάζεται σαφείς ευθύνες στο νοσοκομείο

Διοίκηση	ορίζει υπευθύνους και εξετάζει τα αποτελέσματα με τις κλινικές ομάδες
Κλινικές ομάδες	καταγράφουν τα περιστατικά με βάση τους ορισμούς κάθε δείκτη
Ομάδα κλινικού ελέγχου	επαληθεύει τις καταγραφές σε δείγμα ιατρικών φακέλων
Υπηρεσία ποιότητας	συντονίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δράσεων βελτίωσης

Πηγή: Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024), §§3.3 και 6.2.

Τι ακολούθησε μετά την πιλοτική φάση

2024 Έκδοση του τεχνικού οδηγού του ΠΟΥ με τη μεθοδολογία των 25 δεικτών

2025 Εκπαίδευση ελεγκτών της ANMCS στους 25 δείκτες και σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών

2026 Επανεξέταση της εφαρμογής των δεικτών στα νοσοκομεία της πιλοτικής φάσης

2026 Εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και επαγγελματιών υγείας στο Βουκουρέστι, το Ιάσιο και την Μπίστριτσα

Πηγές: Τεχνικός οδηγός ΠΟΥ (2024) και 7η Τελική Τεχνική Έκθεση NRRP (2026), Output 1.1.

Η ψηφιακή υποστήριξη εξελίχθηκε σε δύο φάσεις

2023 • Ειδική εφαρμογή για την καταγραφή στα έξι πιλοτικά νοσοκομεία

2026 • Πλατφόρμα P4P (Pay For Performance) εγκατεστημένη σε διακομιστές του Υπουργείου Υγείας

Η πλατφόρμα εγκαταστάθηκε και οι χρήστες εκπαιδεύτηκαν. Η τακτική υποβολή δεδομένων από όλα τα επιλέξιμα νοσοκομεία και η χρηματοδότηση του συστήματος αποτελούν επόμενα βήματα.

Πηγές: 3η Τεχνική Έκθεση NRRP (2023), σ. 33· 7η Τελική Τεχνική Έκθεση NRRP (2026).

Τρία διδάγματα για τη διοίκηση νοσοκομείων

01 **Κοινοί ορισμοί πριν από οποιαδήποτε σύγκριση**

Τα νοσοκομεία πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες ένταξης, αποκλεισμού και υπολογισμού.

02 **Η πιλοτική εφαρμογή αναδεικνύει τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων**

Δείχνει ποιο προσωπικό εμπλέκεται, πόσο χρόνο απαιτείται και ποια δεδομένα λείπουν.

03 **Τα αποτελέσματα πρέπει να οδηγούν σε ενέργειες**

Οι κλινικές ομάδες εξετάζουν τα ευρήματα και ελέγχουν αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν.

Σύνθεση του τεχνικού οδηγού και των εγγράφων της πιλοτικής εφαρμογής.